

PERTENECE A **ADER, MANUEL**PROTOCOLO **B173296**INDICADO POR DR/A.: **POSE CABARCOS JULIO (89769)**FECHA **07/04/2025**PROCEDENCIA: **Consultorio**

REGISTRO

COBERTURA: **MEDICUS**AFILIADO **10097779003****ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO****MATERIAL REMITIDO:**

Biopsia de médula ósea

EXAMEN MACROSCOPICO:

Cilindro óseo de 2 cm de longitud.

EXAMEN MICROSCOPICO:

Técnicas efectuadas: Hematoxilina-Eosina, Gomori, Perls y Giemsa

Se realizan técnica inmunohistoquímicas con los siguientes marcadores:

CD34 (células precursoras) y CD117 (células precursoras, eritroblastos y otras)

Material constituido por hueso trabecular y médula ósea.

Espacios medulares ocupados por celularidad en el 100%. Tejido adiposo ausente

Progenies Mieloides aumentadas, con desviación a izquierda. Se observa gigantismo nuclear y citoplasmático.

Progenie Eritroide levemente aumentada, de maduración normoblastica.

Relación Mieloeritroide muy aumentada.

Megacariocitos presentes, en número levemente aumentado. La mayoría presenta cambios dismórficos; se observan micromegacariocitos.

Técnica de Gomori: no se observa aumento de la trama reticulínica.

Técnica de Perls: no se observa aumento del hierro de depósito.

Las técnicas inmunohistoquímicas muestran los siguientes resultados:

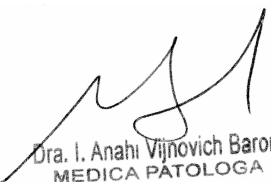
CD34: no se observa aumento de células CD34 positivas.

CD117: se observa leve aumento de células CD117 positivas, las que resulta dificultoso diferenciar de eritroblastos típicos.

DIAGNÓSTICO

Médula ósea con hiperplasia mieloide, cambios megaloblastoides y cambios dismegacariopoyéticos. El cuadro morfológico sugiere investigar síndrome mielodisplásico

AV/sb



Dra. I. Anahi Vijnovich Baron
MEDICA PATOLOGA
M.N. 58541